

İnfantil Kolik

Rome IV temelli pozitif tanı, kırmızı bayrakların taranması, seçilmiş olguda inek sütü proteini eliminasyon denemesi, kanıta dayalı probiyotik ve her şeyden önce yapılandırılmış aile desteği ile gereksiz ilaçtan kaçınma çerçevesi. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Rome IV

İSPA eliminasyon denemesi

L. reuteri DSM 17938

Aile desteği

01 Tanım ve ilk değerlendirme

İnfanıl kolik, Rome IV'e göre bir davranışsal fonksiyonel bozukluktur: 5 aylıktan küçük bir bebekte belirgin neden olmaksızın başlayan ve sonlanan, uzamış ve tekrarlayan huzursuzluk, hırçınlık veya ağlama nöbetlerinin bakıcı tarafından önlenememesi ve yatıştırılamamasıdır. Büyüme geriliği, ateş veya hastalık kanıtı olmamalıdır.

Klinik/araştırma tanısı için ek olarak "üçler kuralı" (≥ 3 saat/gün, ≥ 3 gün/hafta, ≥ 1 hafta) kullanılır. Tanı öyküye dayalı ve pozitifdir; huzursuzluğun büyük çoğunluğu kendini sınırlar ve 4-5 aya doğru geriler. Görev, organik hastalığı öykü ve muayene ile dışlayıp aileyi güçlendirmektir; geniş tetkik kural değildir.

Başlangıç ve bitiş: yaşamın ilk haftaları → 4-5. ay (kendini sınırlayan)

Ağlama zirvesi: ~6. hafta; sıklıkla akşam kümelenmesi

Büyüme normal, muayene normal, ataklar arası bebek iyi

Prevalans yaklaşık %5-20; cinsiyet ve beslenme tipinden bağımsız

Öyküde sorgula

- Ağlama paterni: başlangıç yaşı, süre (saat/gün, gün/hafta), günün saati (akşam kümelenmesi), önlenebilirlik ve yatıştırılabilirlik
- Beslenme: anne sütü / formül, teknik, emme-yutma, aşırı/yetersiz besleme, kusma-regürjitasyon, tartı alımı ve idrar-gaita çıkışı
- İSPA ipuçları: kanlı/mukuslu dışkı, egzama, tekrarlayan kusma-ishal, aile atopi öyküsü
- Dışkı: sıklık, kıvam, kan/mukus; kabızlık veya ishalin eşlik edip etmediği
- Perinatal: gebelik haftası, doğum, ilaçlar; maternal diyet (sütlü ürün), sigara maruziyeti
- Aile: ebeveyn tükenmişliği, uyku yoksunluğu, anksiyete/depresyon, destek ağı, başa çıkma; sarsılmış bebek riskinin taranması
- Kırmızı bayrak taraması: ateş, safralı/fışkırır kusma, letarji, kilo alamama, apne

Muayenede değerlendir

- Büyüme: kilo, boy, baş çevresi persentilleri ve eğri; büyümede duraklama alarmıdır
- Genel: ataklar arası refah, canlılık, hidrasyon, renk, tonus; ateş ölçümü
- Karın: distansiyon, kitle, organomegali, hassasiyet, barsak sesleri; inguinal/skrotal herni (inkarserasyon)
- Anorektal: fissür, dermatit; gizli kan gerektiğinde
- Gizli ağrı odakları: gözde kornea abrazyonu, parmak/penis saç turnikesi, otit, aftöz lezyon, ekstremiteler

- Nörolojik: fontanel (bombeleşme), göz dibi, retinal kanama, morluk/ekimoz — kötü muameleyi ekarte et
- Cilt: atopik dermatit (İSPA ile birliktelik)

Kırmızı bayrak yoksa ve büyüme normalse infantil kolik bir dışlama tanısı değil **pozitif klinik tanıdır**; rutin kan tetkiki, görüntüleme, pH-empedans veya endoskopi gerekmez. Aşırı tetkik ve gereksiz ilaç, aile anksiyetesini ve iyatrojenik riski artırır.

02 Katkıda bulunan mekanizmalar

İnfanıl kolik tek nedenli değildir; büyük çoğunlukta selim, kendini sınırlayan gelişimsel bir davranış varyantıdır. Yine de küçük bir alt grupta düzeltilebilir katkılar (inek sütü proteini duyarlılığı, beslenme tekniği, disbiyoz) bulunur. Baskın katkıyı öngörmek, hedefli ve zararsız bir müdahale seçimini yönlendirir.

İnek sütü proteini duyarlılığı (İSPA)

- Alt grupta huzursuzluğu tetikler; kanlı-mukuslu dışkı, egzama, atopi ipuçları
- Non-IgE aracılı; IgE testleri tanısal değil
- Hedef: 2-4 haftalık eliminasyon-provokasyon denemesi

Bağırsak mikrobiyotası / disbiyoz

- Koliği olan bebeklerde düşük çeşitlilik, artmış proteobakteri, düşük laktobasil-bifidobakteri
- Gaz üretimi ve düşük dereceli inflamasyon ile ilişkilendirilmiştir
- Hedef: seçili olguda L. reuteri denemesi

Motilite / gaz / bağırsak immatüritesi

- Aşırı yutulan hava, gaz retansiyonu, artmış motilin ve barsak-gerilim algısı
- Geçici; olgunlaşma ile 4-5 ayda geriler
- Hedef: beslenme tekniği, geçirtme; ilaç gereksiz

Beslenme teknik faktörleri

- Hatalı tutuş-emzik, hızlı akış, aşırı/yetersiz besleme, aşırı yutma
- Nadiren geçici laktoz aşırı yükü
- Hedef: pozisyon, tempo, emzirme desteği

Nöro-davranışsal regülasyon

- Ağlama-uyku düzeninde gelişimsel varyasyon, duyusal regülasyon farkı
- Normal ağlama eğrisinin (6. hafta zirvesi) üst ucu
- Hedef: yatıştırma rutinleri, uyaran yönetimi

Ebeveyn-bebek etkileşimi ve çevre

- Ebeveyn tükenmişliği, anksiyete-depresyon, algı-yanıt döngüsü
- Maternal sigara maruziyeti ile ilişki bildirilmiştir
- Hedef: güvence, uyku-nöbet paylaşımı, ruh sağlığı desteği

03 Karar akışı

İlk çatal kırmızı bayrak varlığıdır; ikinci çatal İSPA lehine ipuçlarıdır. Alarm yoksa yol, tetkik değil; güvence, aile desteği ve gerektiğinde zararsız-hedefli denemedir.

BAŞLANGIÇ

<5 aylık bebekte uzamış, açıklanamayan ağlama-huzursuzluk

Önlenemeyen ve yatıştırılamayan nöbetler; üçler kuralı (≥ 3 saat/gün, ≥ 3 gün/hafta) klinik eşiği tanımlar.

ADIM 1

Öykü + tam muayene + büyüme eğrisi

Beslenme, dışkı (kan/mukus), atopi, aile öyküsü ve tükenmişlik; gizli ağrı odakları (kornea, saç turnikesi, herni) ve nörolojik bakı.

KARAR 1

Kırmızı bayrak var mı?

Ateş, safralı/fıskırır kusma, kilo alamama, letarji, apne, kanlı dışkı, distansiyon, bombeleşmiş fontanel, ekimoz, gecikmiş başlangıç/persistans.

EVET → Organik hastalığı ekarte et

HAYIR → İnfantil kolik (pozitif tanı)

HEDEFLİ TETKİK

Semptoma yönelik acil değerlendirme

İnvajinasyon/herni için US, idrar tahlili-kültürü, sepsis-menenjit taraması, göz muayenesi, ekstremiteler/turnike; kötü muamele şüphesinde göz dibi-görüntüleme.

TEMEL YAKLAŞIM

Güvence + yapılandırılmış aile desteği

Selim ve kendini sınırlayan seyir açıklanır; yatıştırma, geçirtme, beslenme tekniği; ebeveyn tükenmişliği ve sarsılmış bebek riski ele alınır.

KARAR 2

İSPA lehine ipucu var mı? (kanlı-mukuslu dışkı, egzama, atopi, kusma-ışhal)

Şiddetli, dirençli olgu veya alerjik işaretler eşlik ediyorsa hedefli eliminasyon denemesi düşünülür.

EVET → 2-4 haftalık eliminasyon denemesi

HAYIR → İlaçsız izlem

İSPA DENEMESİ

İZLEM

Formül: eHF · Anne sütü: maternal süt eliminasyonu

Belirgin düzelme varsa provokasyon ile doğrula; net yanıt yoksa denemeyi sonlandır ve süt ürününü geri ver. Amaç gereksiz uzun kısıtlamadan kaçınmak.

Güvence + zamanla gerileme; seçili anne sütü alanda *L. reuteri*

Rutin simetikon, antikolinergik, asit baskılayıcı ve bitkisel ürünlerden kaçın. 1-2 haftada yeniden değerlendir; yeni alarmda tekrar gözden geçir.

Tipik infantil kolikte rutin laboratuvar veya görüntüleme gerekmez; tetkik yalnızca kırmızı bayrak ya da spesifik şüpheyile yönlendirilir. Aşağıdaki basamaklar "alarm varsa" mantığıyla, semptom-hedefli okunur.

Kırmızı bayrak / şüphe temelli hedefli değerlendirme		
BASAMAK / HEDEF	TEST	ENDİKASYON / NOT
Basamak 0 · Tipik kolik	Tetkik yok — öykü, muayene, büyüme eğrisi	Alarm yoksa: pozitif tanı; kan/görüntüleme/endoskopi endike değil
İSPA şüphesi	Eliminasyon-provokasyon denemesi (klinik tanı); gerekiyorsa gaita gizli kan	IgE/deri testi non-IgE İSPA'yı dışlamaz-tanımlamaz; tanı diyet yanıtı ile konur
Ateş / enfeksiyon	Tam idrar + idrar kültürü, tam kan, CRP; eşiğe göre sepsis-menenjit taraması	İYE ve gizli enfeksiyon "açıklanamayan ağlamanın" klasik taklitçileridir
Akut karın şüphesi	Batın ultrasonografisi (invajinasyon, malrotasyon-volvulus, inkarsere herni)	Safralı kusma, kanlı-jölemsi dışkı, distansiyon, ataklı şiddetli ağlama
Lokelize ağrı odağı	Floresein ile göz (kornea abrazyonu); ekstremiteler-penis saç turnikesi araması	Muayene ile tanı; kolayca gözden kaçır, mutlaka ara
Kötü muamele şüphesi	Göz dibi (retinal kanama), nörogörüntüleme, iskelet taraması	Bombeleşmiş fontanel, ekimoz, letarji, apne, tutarsız öykü
Kilo alamama / kusma	Beslenme değerlendirmesi; hedefli metabolik-elektrolit	Büyüme duraklaması koliği aşan bir sorunu işaret eder

Gastroözofageal reflü koliğinin nedeni değildir: huzursuz bir bebekte ampirik asit baskılayıcı (PPI/H2) başlatmak etkisizdir ve enfeksiyon riskini artırır; GÖRH tanısı ayrı ve hedefli konur. Benzer şekilde soya bazlı formül İSPA denemesinde ilk seçenek değildir (çapraz reaktivite).

Aşağıdakilerden herhangi biri infantil kolik tanısını dışlar veya sorgulatır ve semptom-hedefli acil değerlendirme gerektirir.

● Ateş veya toksik-hasta görünüm

● Kilo alamama / büyümede duraklama

● Safralı veya fışkırır (projektil) kusma

● Kanlı veya jölemsi dışkı

● Abdominal distansiyon, ele gelen kitle, inkarsere herni

● Letarji, hipotoni, beslenme reddi

● Apne, siyanoz veya solunum güçlüğü

● Tiz-perçinleyici (high-pitched) ağlama

● Bombeleşmiş fontanel, retinal kanama, ekimoz (kötü muamele)

● Başlangıç >4-5 ay veya 5. aydan sonra persistan huzursuzluk

● Ataklı-şiddetli, bacakları karına çekme (invajinasyon şüphesi)

● Ebeveyn tükenmişliği / depresyon / bebeğe zarar verme kaygısı

Sarsılmış bebek sendromu (kafa travması) kolikin en ciddi komplikasyonudur: bakıcıya, uzayan ağlamada bebeği güvenli bir yere bırakıp uzaklaşmayı ve asla sarsmamayı açıkça öğret; ebeveyn tükenmişliğini her vizitte tara.

Tedavinin temel taşı ilaç değil; güvence, eğitim ve aile desteğidir. Farmakoterapinin çoğu etkisiz veya zararlıdır ve rutin önerilmez. Hedefli-zararsız iki müdahale seçilir: (1) İSPA lehine ipucu olan olguda 2-4 haftalık eliminasyon denemesi, (2) özellikle anne sütü alan bebekte L. reuteri denemesi. Her müdahale süreli denenir ve yanıtızsza kesilir.

Pediyatrik infantil kolikte kanıta dayalı, dozlu yaklaşım**BASAMAK / AJAN****DOZ****Güvence + aile desteği (tüm hastalar)**

—

Beslenme tekniği optimizasyonu

—

İSPA denemesi · Formül alan (eHF)**Ekstansif hidrolize formül, 2-4 hafta; yanıt varsa****İSPA denemesi · Anne sütü alan****Maternal inek sütü proteini eliminasyonu 2-4 ha**

BASAMAK / AJAN	DOZ
Probiyotik · L. reuteri DSM 17938	1x10 ⁸ CFU/gün (5 damla), tek doz, 3-4 hafta
Simetikon	Önerilmez
Disiklomin / disikloverin	Kontrendike (<6 ay)
Asit baskılayıcı (PPI / H2)	Endike değil
Bitkisel/şeker çözeltileri (rezene, papatya, sükroz)	Rutin önerilmez
Laktaz damlası / laktozsuz formül	Rutin önerilmez

Yaklaşım: Önce güvence ve aile desteği; ipucu varsa 2-4 haftalık İSPA denemesi ve/veya anne sütü alanda L. reuteri. Her denemeyi süreli uygula, yanıtızsza kes ve kısıtlamayı geri al. Simetikon,

07 İzlem ve yönetim ilkeleri

İnfantil kolik neredeyse daima 4-5 ayda geriler; hedef, ebeveyni güvenle desteklemek, organik hastalığı kaçırmamak ve iyatrojenik zarardan (gereksiz ilaç, uzun kısıtlama, aşırı tetkik) kaçınmaktır. Ailenin duygusal yükünün doğrudan ele alınması en tutarlı sonucu verir.

İzlem

- 1-2 haftada yeniden değerlendir; büyüme eğrisini ve refahı izle, yeni kırmızı bayrağı tara
- İSPA denemesinde net yanıt yoksa 2-4 haftada süt ürününü geri ver; kalıcı gereksiz kısıtlamayı önle
- L. reuteri denemesinde yanıt yoksa sürdürme; ilacı kes
- Ağlama-uyku-beslenme günlüğü ile aileye somut geri bildirim ver; 4-5 ayda gerilemeyi öngör
- 5. aydan sonra persistan huzursuzlukta tanıyı yeniden gözden geçir (İSPA, GÖRH, nörogelişimsel)

Aile desteği ve dirençli olgu

- Nöbet paylaşımı, mola alma, güvenli bırak-uzaklaş stratejisi; asla sarsmama eğitimini pekiştir
- Maternal depresyon-anksiyeteyi tara ve yönlendir; sosyal destek ağını güçlendir
- Yatıştırma: kundak, ritmik hareket, beyaz gürültü, ten tene temas, uyaran azaltma
- Dirençli-şiddetli olguda İSPA denemesini gözden geçir; büyüme ve alarm bulgularını tekrar değerlendir
- Farmakoterapiyi büyütme; multidisipliner destek (emzirme danışmanı, ruh sağlığı) kur

Etkin güvence, beslenme desteği ve ebeveyn iyilik halinin korunması; kısa süreli-hedefli denemelerle (İSPA eliminasyonu, seçili olguda L. reuteri) birleştğinde, gereksiz ilaç ve tetkik yükü olmadan en kalıcı yararı sağlar.

Kaynaklar

1. Zeevenhooven J, Koppen IJ, Benninga MA. The New Rome IV Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders in Infants and Toddlers. *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr.* 2017;20(1):1-13.
2. Benninga MA, Nurko S, Faure C, Hyman PE, St James Roberts I, Schechter NL. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler (Rome IV). *Gastroenterology.* 2016;150(6):1443-1455.
3. Koletzko S, Niggemann B, Arato A, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow's-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2012;55(2):221-229.
4. Sung V, D'Amico F, Cabana MD, et al. Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. *Pediatrics.* 2018;141(1):e20171811.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulama koşullarının yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre doğrulanmalıdır.